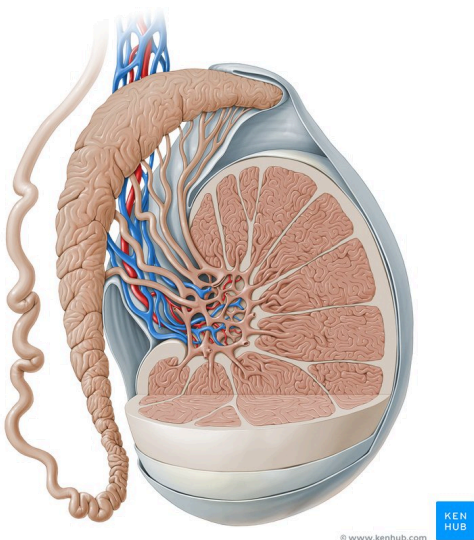




NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4 semestre 2026A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE: Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR REALIZAR: EPIDIDECTOMIA			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
1. ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción) Consiste en la extirpación parcial o total del epidídimo debido a la presencia de quistes para prevenir los abscesos. No es recomendable ya que causa infertilidad. Se hace sobre todo en quistes sebáceos ya que tienen mayor riesgo de formar fistulas. 1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción). ANATOMÍA  © www.kenhub.com Los testículos son glándulas reproductoras masculinas localizadas en el escroto. Poseen forma ovoidea, con 4 a 6cm de longitud y con un peso de 10-15 gramos.			



El escroto es usualmente asimétrico, con un testículo más inferior que el otro (usualmente el izquierdo). Los testículos están suspendidos dentro del escroto por el cordón espermático.

Capas del testículo

- Piel o escroto
- Dartos
- Capa celular subcutánea
- Fascia espermática externa
- Musculo cremáster
- Fascia espermática interna
- Túnica vaginal del testículo



Conductos espermáticos

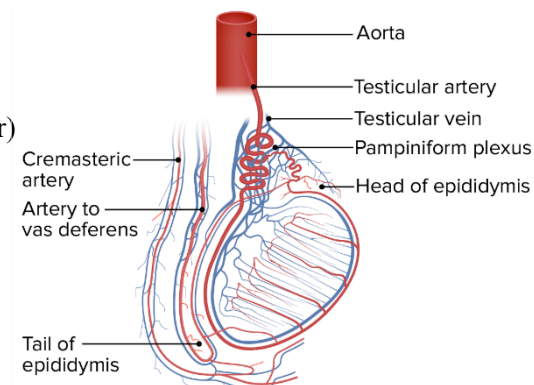
- Conductillos eferentes: Expulsan a los espermatozoides al conducto epidídimo
- Conducto del epidídimo: Maduración y almacenamiento de espermatozoides
- Conducto deferente: Involucrado en el transporte de los espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos eyaculadores.

Irrigación y drenaje venoso

- Arteria testicular
- Arteria cremastérica (rama de la arteria epigástrica inferior)
- Arteria del conducto deferente (rama de la arteria vesical inferior)
- Plexo pampiniforme y la vena testicular

Inervación

- Plexo testicular



FISIOLOGIA

Los testículos producen y almacenan las células germinales masculinas (espermatozoides) y secretan hormonas sexuales masculinas llamadas andrógenos (principalmente testosterona)



1.3. Lista de chequeo:

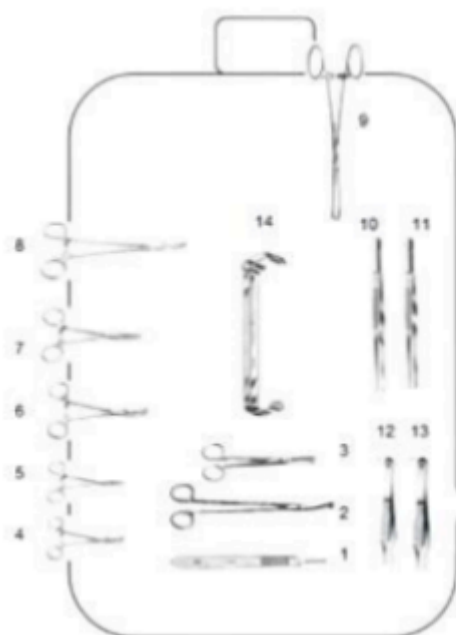
INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS 😊	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta de plastia	Paquete de ropa Gasas Compresas Torundas Apositos Hoja de bisturí #15 Aseptojeringa Guantes Electrobisturí Frasco de patología Dren de pen rose (opcional)	TCS: Poliglactina 910 2/0 con aguja ½ circulo redonda de 27 mm. Fascia y musculo: Poliglactina 910 1 o 0 con aguja ½ circulo redonda de 37 mm. Ligadura de los lobulillos y conducto deferente: Seda precortada 3/0 y 4/0 Escroto: Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda	Solución salina Lidocaína al 1% sin epinefrina



2. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- a. Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

Mesa de Mayo



- 1) Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 2) Tijeras de Metzembaum
- 3) Tijeras de Mayo recta
- 4) Pinzas Kelly curva
- 5) Pinzas Kelly recta
- 6) Pinzas Kelly Adson
- 7) Pinzas Rochester curva
- 8) Pinzas Rochester recta
- 9) Pinzas Allix
- 10) Pinza de Disección Rusa
- 11) Pinza de Disección sin garra larga
- 12) Pinza de Disección con garra larga
- 13) Pinza de Disección sin garra corta
- 14) Disección Adson con garra
- 15) Separadores de Farabeuf

Mesa de Reserva



1. Equipo de plastia
2. Coca con suero
3. Coca
4. Canula de Yankawer
5. Porta agujas
6. Suturas
7. Pinza de campo de backhause
8. Compresas
9. Lapicero del electro bisturí
10. Paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succion



2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

DECUBITO SUPINO



2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):





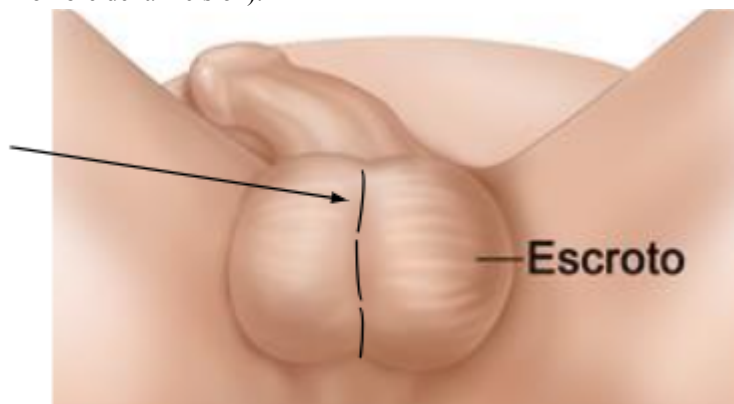
3. ETAPA DE EJECUCION:

- a) Anestesia (escribir el tipo de anestesia):

Anestesia regional o general.

- b) Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):

**Incisión escrotal
siguiendo el pliegue**



- c) Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTAL
Incisión escrotal	Mango de bisturí #3 Hoja de bisturí #15
Hemostasia	Electrobisturí
Incisión de la túnica vaginal	Pinza mosquito curva Tijeras de plastia
Disección y tracción de la cabeza del epidídimo	Pinza Babcock Tijera de metzenbaum Pinza de disección fina
Sección y ligadura del conducto deferente	Seda precortada 3/0
Se hace cierre de las capas del escroto y se realiza curación	Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda



Se puede dejar dren si el quiste era muy grande.

**FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES**

FIRMA ESTUDIANTE: _____

FIRMA DOCENTE: _____